

Psicosis

El término “psicosis” implica un deterioro marcado en la prueba de realidad, evidenciado con la alteración del estado mental, extendiéndose al pensamiento, respuesta afectiva y comunicación con los demás.

La psicosis es un trastorno mental complejo que se define como una alteración grave en la percepción de la realidad. Se caracteriza por la presencia de síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y, en ocasiones, comportamiento desorganizado o catatónico. Esta condición puede manifestarse en diferentes trastornos psiquiátricos y enfermedades médicas subyacentes, lo que hace de su estudio y tratamiento un desafío interdisciplinario.

La psicosis no es una enfermedad en sí misma, sino un conjunto de síntomas que pueden estar presentes en diversas condiciones psiquiátricas y médicas. Los síntomas principales incluyen:

1. Alucinaciones: Experiencias sensoriales sin estímulos externos. Las más comunes son las auditivas (por ejemplo, escuchar voces), aunque también pueden ser visuales, táctiles, gustativas u olfativas.
2. Delirios: Creencias falsas, fijas y resistentes a la evidencia en contra. Estos pueden incluir ideas paranoides, de grandiosidad, de referencia, entre otros.
3. Pensamiento desorganizado: Reflejado en el lenguaje, que puede volverse incoherente, tangencial o ilógico.
4. Comportamiento desorganizado o catatónico: Conductas impredecibles, agitación extrema o, por el contrario, inmovilidad y mutismo.

Clasificación de la psicosis:

Etiología y clasificación de los trastornos psicóticos.

Trastornos psicóticos primarios							
Temporalidad	1 día a 1 mes	1 mes a 6 meses	Más de 6 meses	Más de 1 mes	Más de 7 días	Más de 2 semanas	Más de 2 semanas
Enfermedad psiquiátrica	Trastorno psicótico breve	Trastorno esquizofreniforme	Esquizofrenia	Trastorno delirante/delirante compartido	Manía	Depresión psicótica	Trastorno esquizofrénico
Trastornos psicóticos secundarios							
Sustancias de abuso	Alucinógenos, <i>cannabis</i> , cocaína, anfetaminas, abstinencia de alcohol, abstinencia de hipnótico a sedantes						
Fármacos	Esteroides, simpaticomiméticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, benzodiacepinas, antidepresivos, estimulantes de venta libre (anorexígenos)						
Neurológicos	Demencia, epilepsia, enfermedad de Huntington, evento vascular cerebral, encefalitis, hidrocefalia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Pick						
Infecciosos	VIH/sida, neuroinfecciones, paludismo, neurosífilis						
Endocrinos	Enfermedad de Addison, neurolupus (lupus eritematoso sistémico), hipotiroidismo-hipertiroidismo, hipoparatiroidismo-hiperparatiroidismo, hipopituitarismo						
Metabólicos	Delirio, uremia, hipoglucemia-hiperglucemia, hipoxia, hiponatremia, hipocalcemia-hipercalcemia, hipomagnesemia-hipermagnesemia						
Diversos	Traumatismo craneoencefálico, neoplasias, porfiria aguda intermitente, enfermedad de Wilson, exposición a metales pesados						

Antipsicóticos típicos (primera generación)

Son inhibidores competitivos de una variedad de receptores, pero sus efectos antipsicóticos reflejan el bloqueo competitivo de los receptores de dopamina D2. Los antipsicóticos de primera generación tienen mayores probabilidades de relacionarse

con trastornos del movimiento conocidos como síntomas extrapiramidales, en especial fármacos que forman una unión estrecha con los neuroreceptores dopaminérgicos, como haloperidol. Los trastornos del movimiento son un tanto menos probables con medicamentos que se unen de una forma menos potente, como clorpromazina. Ningún fármaco es clínicamente más efectivo que otro.

- Baja potencia

Clorpromazina

Tioridazina

- Alta potencia

Flufenazina

Haloperidol

Loxapina

Molindona

Pimozida

Clorpromazina

★ Mecanismo de acción:

Antipsicótico típico que actúa principalmente mediante el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2 en el sistema nervioso central (SNC). Este bloqueo es responsable de su efecto terapéutico en los síntomas positivos de los trastornos psicóticos, como las alucinaciones y los delirios.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Relativamente baja (20-50%), debido a un marcado metabolismo de primer paso hepático.
- Distribución: Alto (~7 L/kg), debido a su lipofilicidad, lo que facilita su acumulación en tejidos altamente perfundidos como el cerebro, hígado y pulmones.
- Metabolismo: Principalmente hepático a través de las enzimas del citocromo P450, especialmente CYP2D6, CYP1A2 y CYP3A4.
- Excreción: Predominantemente a través de la bilis (metabolitos excretados en heces) y, en menor medida, por los riñones (metabolitos en orina).

★ Indicaciones principales:

Agitación psicomotriz: psicosis aguda, crisis maniaca, acceso delirante, síndrome confusional; proceso psicogeriatrico. Proceso psicótico: esquizofrenia, síndrome delirante crónico. Cura de sueño.

★ Indicaciones alternativas:

Insomnio refractario, psicosis organica, dolor crónico, enfermedad de huntington

★ Contraindicaciones relativas:

- Enfermedad cardiovascular (arritmias, prolongación del intervalo QT).
- Insuficiencia renal moderada a severa.
- Glaucoma de ángulo cerrado.
- Hiperplasia prostática con retención urinaria.

- Trastornos neurológicos (Parkinson, epilepsia).
- Embarazo y lactancia (usar con precaución).
- Pacientes geriátricos (riesgo de efectos adversos).
- ★ **Contraindicaciones absolutas:**
 - Hipersensibilidad a la clorpromazina o fenotiazinas.
 - Depresión severa del SNC (coma, intoxicación por alcohol u opiáceos).
 - Hipotensión severa o choque.
 - Insuficiencia hepática grave.
- ★ **Interacciones:**
 - Antagoniza los efectos de: levodopa.
 - Absorción disminuida por: sales, óxidos e hidróxidos de Al, Mg o Ca (espaciar 2 h).
 - Riesgo de hipotensión ortostática con: antihipertensivos.
 - Riesgo de prolongación QT con: quinidina, procainamida, amiodarona, mibefradil, eritromicina, cotrimoxazol, trimetoprim-sulfametoxazol, azitromicina, ketoconazol, pentamidina, cisaprida, probucol, antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, haloperidol y otras fenotiazinas, agentes organofosforados y vasopresina.
 - Adición de efectos con: depresores del SNC.
 - Adición de reacciones adversas atropínicas con: atropina, sustancias atropínicas, imipramina, anti- H_1 , sedantes, antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antiespasmódicos atropínicos, disopiramida. Con antidiabéticos a dosis altas: elevación de la glucemia.

★ **Efectos secundarios/adversos:**

Hiperprolactinemia, amenorrea; aumento de peso, intolerancia a la glucosa; ansiedad; sedación, somnolencia, discinesia, acatisia, excitación motora; hipertonía, convulsión; prolongación del intervalo QT; hipotensión ortostática; sequedad de boca, estreñimiento.

Haloperidol

★ **Mecanismo de acción:**

Neuroléptico perteneciente a la familia de las butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales, y por consiguiente, está clasificado entre los neurolépticos de gran potencia. Haloperidol no posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica.

★ **Farmacocinética:**

- Absorción: biodisponi
- Distribución: Se distr
- Metabolismo: La mo
- Excreción: La mayor

★ **Indicaciones principales:**

Como neuroléptico en:

- delirios y alucinaciones en: esquizofrenia aguda y crónica, paranoia, confusión aguda, alcoholismo (síndrome de Korsakoff)

- Delirio hipocondríaco.

-Trastornos de la personalidad: paranoide, esquizoide, esquizotípica, antisocial, límite y otras personalidades.

En el tratamiento de la agitación psicomotriz en:

- Manía, demencia, retraso mental, alcoholismo.-

- Trastornos de la personalidad: obsesivo-compulsiva, paranoide, histriónica y otras personalidades.

- Agitación, agresividad y conductas de evitación en pacientes geriátricos.

- Trastornos de la conducta y del carácter en niños.

- Movimientos coreicos.

- Hipo persistente.

- Tics, tartamudeo y síntomas del síndrome de Gilles de la Tourette y coreas relacionadas.

En anestesiología:

- Premedicación y mezclas anestésicas.

Como antiemético en:

Náuseas y vómitos de diversa etiología. Haloperidol es el medicamento de elección cuando los medicamentos clásicos para el tratamiento de las náuseas y los vómitos no son suficientemente efectivos.

★ Indicaciones alternativas:

Agitación severa y delirium: En emergencias psiquiátricas o médicas.

Tics y síndrome de Tourette: Para reducir movimientos involuntarios severos.

Náuseas y vómitos refractarios: Especialmente inducidos por quimioterapia o cirugía.

Manía aguda: Como tratamiento a corto plazo para estabilización inicial.

Hipo persistente: En casos intratables que no responden a otros fármacos.

Corea de Huntington: Para controlar movimientos involuntarios y síntomas conductuales.

Demencia: Control de síntomas disruptivos graves (uso controvertido, con precaución).

★ Contraindicaciones relativas:

- Insuficiencia hepática o renal: Mayor riesgo de toxicidad por acumulación.
- Trastornos cardiovasculares: Hipotensión, insuficiencia cardíaca, o bradicardia.
- Epilepsia: Riesgo de disminución del umbral convulsivo.
- Glaucoma de ángulo cerrado: Puede agravar la condición por sus efectos anticolinérgicos.
- Pacientes geriátricos: Mayor sensibilidad a efectos extrapiramidales y sedación.
- Embarazo y lactancia: Riesgo potencial para el feto/neonato (categoría C de la FDA)

★ **Contraindicaciones absolutas:**

- Hipersensibilidad al haloperidol o a derivados butirofenonas.
- Estado comatoso o depresión severa del sistema nervioso central.
- Prolongación del intervalo QT o antecedentes de torsades de pointes.
- Parkinsonismo severo o enfermedad de Parkinson avanzada.
- Demencia con cuerpos de Lewy: Riesgo de empeoramiento de síntomas motores y cognitivos.

★ **Interacciones:**

- Riesgo de torsade de pointes con: sustancias que prolonguen el intervalo QT.
- Concentraciones plasmáticas aumentadas con: itraconazol, nefazodona, buspirona, venlafaxina, alprazolam, fluvoxamina, quinidina, fluoxetina, sertralina, clorpromazina y prometazina.
- Niveles plasmáticos disminuidos por: carbamazepina, fenobarbital, rifampicina.
- Potencia la depresión del SNC de: alcohol, hipnóticos, sedantes o analgésicos potentes.
- Antagoniza la acción de: adrenalina.
- Disminuye el efecto de: levodopa.
- Aumenta niveles plasmáticos de: antidepresivos tricíclicos.

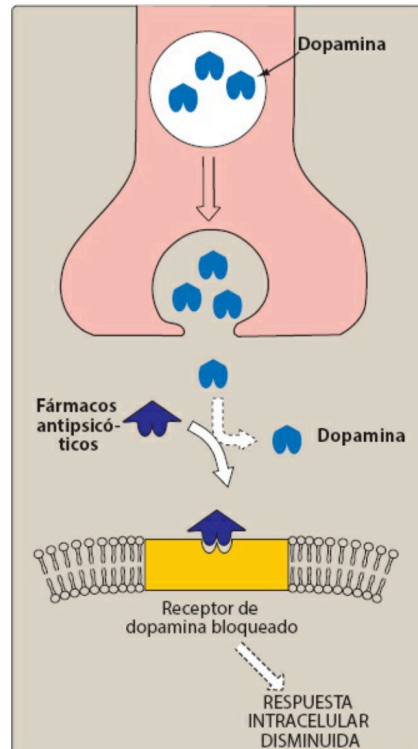
★ **Efectos secundarios/adversas:**

Agitación, insomnio; depresión, trastorno psicótico; trastorno extrapiramidal, hipercinesia, cefalea, discinesia tardía, crisis oculogíricas, distonía, discinesia, acatisia, bradicinesia, hipocinesia, hipertonía, somnolencia, fascies parkinsoniana, temblor, mareo; deterioro visual; hipotensión ortostática, hipotensión; estreñimiento, boca seca, hipersecreción salival, náuseas, vómitos; prueba anormal de función hepática, erupción; retención urinaria; disfunción eréctil; peso aumentado, peso disminuido.

Antipsicóticos atípicos

Tienen una menor incidencia de síntomas extrapiramidales que en los agentes de primera generación, pero se relacionan con un mayor riesgo de efectos adversos metabólicos, como diabetes, hipercolesterolemia y aumento de peso. Los fármacos de segunda generación deben su actividad única al bloqueo de los receptores tanto de serotonina como de dopamina.

La mayoría de los agentes de segunda generación ejercen parte de su acción a través de la inhibición de los receptores de serotonina (5-HT), en particular los receptores 5-HT_{2A}. Clozapina tiene una alta afinidad por los receptores D₁, D₄, 5-HT₂, muscarínicos y α -adrenérgicos, pero también es un débil antagonista del receptor de dopamina D₂.



Aripiprazol
 Asenapina
 Cariprazina
 Clozapina
 Iloperidona
 Quetiapina

Aripiprazol

★ Mecanismo de acción:

Antipsicótico. Agonista parcial de receptores D_2 de dopamina y $5-HT_{1a}$ de serotonina y antagonista de receptores $5-HT_{2a}$ de serotonina.

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad del 87%
- Distribución: Alto (~4.9 L/kg), lo que indica buena penetración tisular, incluyendo el sistema nervioso central (SNC).
- Metabolismo: Hepática, mediada por las enzimas del citocromo P450, específicamente CYP3A4, CYP2D6. El principal metabolito activo es el dehidroaripiprazol, que tiene una potencia similar al compuesto original y contribuye significativamente a su efecto terapéutico.
- Excreción: 25% por orina y 75% por heces.

★ Indicaciones principales:

- Vía oral: esquizofrenia en ads. y adolescentes >15 años. Episodios maníacos moderados o severos en trastorno bipolar I en ads. y adolescentes >13 años y en la prevención de recaídas.

- IM liberación normal: control rápido de la agitación y alteraciones del comportamiento en esquizofrenia, cuando el tto. oral no es adecuado.
- IM liberación prolongada: tto. de mantenimiento en la esquizofrenia en pacientes ads. Estabilizados con aripiprazol oral.

★ Indicaciones alternativas:

Trastorno depresivo mayor: Como tratamiento adjunto a antidepresivos.

Trastorno bipolar: Para la manía aguda y mantenimiento.

Trastorno del espectro autista: Para controlar la irritabilidad y conductas disruptivas.

Trastorno de Tourette: Para tics severos.

Psicosis no esquizofrénica: Como tratamiento de psicosis secundaria.

Agitación y agresividad: En situaciones de agitación severa.

Trastornos de ansiedad: En casos refractarios, aunque no es su uso principal.

★ Contraindicaciones relativas:

- Enfermedad cardiovascular: Como arritmias, insuficiencia cardíaca o hipotensión, ya que aripiprazol puede afectar la función cardíaca.
- Insuficiencia hepática o renal: Uso con precaución, ya que su metabolismo y eliminación dependen del hígado y los riñones.
- Epilepsia: Puede reducir el umbral convulsivo, aumentando el riesgo de crisis.
- Glaucoma de ángulo cerrado: Puede aumentar la presión intraocular.
- Pacientes geriátricos: Pueden ser más sensibles a efectos sedantes y extrapiramidales.
- Embarazo y lactancia: Se debe usar con precaución, ya que el medicamento atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche materna.

★ Contraindicaciones absolutas:

- Hipersensibilidad al aripiprazol o a cualquier componente de la fórmula.
- Coma o depresión grave del sistema nervioso central (SNC).
- Prolongación del intervalo QT o antecedentes de torsades de pointes.
- Parkinsonismo severo o enfermedad de Parkinson avanzada.

★ Interacciones:

- Concentración plasmática aumentada con: quinidina, fluoxetina, paroxetina, ketoconazol, itraconazol e inhibidores de la proteasa de VIH.
- Concentración plasmática disminuida con: carbamazepina, rifampicina, rifabutina, fenitoína, fenobarbital, primidona, efavirenz, nevirapina, hierba de San Juan.
- Aumenta el efecto de: ciertos agentes antihipertensivos.
- Precaución con: alcohol u otras sustancias de acción central, sustancias que produzcan prolongación del intervalo QT o trastornos electrolíticos.
- Concomitante con ISRS/IRSN riesgo de s. serotoninérgico.

★ Efectos secundarios/adversas:

Diabetes mellitus; insomnio, agitación, ansiedad; cefalea, acatisia, somnolencia/sedación, temblor, trastorno extrapiramidal, mareo; visión borrosa; náuseas, vómitos, dispepsia, estreñimiento, hipersecreción salivar; fatiga; taquicardia; hipotensión ortostática; agresión; hipo.

Después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia se ha observado: crisis oculógira; fotofobia.

Clozapina

★ Mecanismo de acción:

Acción bloqueante débil sobre receptores dopaminérgicos (D_1 , D_2 , D_3 y D_5), y potentes efectos sobre el receptor D_4 , además, potente efecto anti-alfa-adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico y disminución del nivel de vigilia.

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad 50-60%
- Distribución: ~1.6 L/kg, lo que indica una distribución amplia en los tejidos, incluido el sistema nervioso central.
- Metabolismo: Hepática, mediada por las enzimas del citocromo P450 (CYP): CYP1A2: Principal isoenzima responsable del metabolismo de la clozapina. CYP3A4, CYP2C19 y CYP2D6: Contribuyen en menor grado.
- Excreción: ~50% en la orina, ~30% en las heces. La clozapina no se elimina sin cambios en cantidades significativas, ya que su metabolismo es extenso.

★ Indicaciones principales:

- Tratamiento de la esquizofrenia resistente.

Está indicado en pacientes esquizofrénicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrénicos que presenten reacciones adversas neurológicas graves y no tratables con otros fármacos antipsicóticos, incluyendo un antipsicótico atípico. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clínica satisfactoria a pesar de haber utilizado como mínimo dos tratamientos diferentes con antipsicóticos, incluyendo un antipsicótico atípico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.

- Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson.

Trastornos psicóticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estándar.

★ Indicaciones alternativas:

- Psicosis en enfermedad de Parkinson: Eficaz en el control de síntomas psicóticos sin agravar los síntomas motores.
- Trastorno esquizoafectivo: Cuando otros tratamientos son ineficaces.
- Trastornos del espectro bipolar: Para episodios psicóticos graves resistentes a otros antipsicóticos.

- Trastorno límite de la personalidad: En casos graves con impulsividad o síntomas psicóticos refractarios.
- Trastorno de conducta violenta o autolesiva: En esquizofrenia o condiciones psiquiátricas crónicas.
- Prevención del suicidio: En pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, demostrado como eficaz.

★ **Contraindicaciones relativas:**

- Leucopenia o neutropenia leve: Requiere monitoreo estrecho del recuento leucocitario.
- Insuficiencia hepática o renal: Ajuste de dosis necesario debido a su metabolismo y excreción.
- Hipotensión o enfermedades cardiovasculares: Riesgo de hipotensión ortostática y colapso circulatorio.
- Epilepsia controlada: Puede reducir el umbral convulsivo, aumentando el riesgo de crisis.
- Pacientes geriátricos: Mayor sensibilidad a efectos adversos, como hipotensión y sedación.
- Historia de glaucoma de ángulo cerrado: Riesgo de aumento de presión intraocular.
- Enfermedad pulmonar crónica: Mayor riesgo de depresión respiratoria.
- Embarazo y lactancia: Usar solo si el beneficio supera el riesgo, ya que atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

★ **Contraindicaciones absolutas:**

- Hipersensibilidad a la clozapina o sus componentes.
- Agranulocitosis previa o mielosupresión severa relacionada con clozapina.
- Miopatía cardíaca o antecedentes de miocarditis inducida por clozapina.
- Epilepsia no controlada o convulsiones recurrentes severas.
- Estado comatoso o depresión grave del sistema nervioso central (SNC).
- Uso concomitante con medicamentos que prolongan el intervalo QT: Mayor riesgo de arritmias.

★ **Interacciones:**

- Aumento del riesgo y/o gravedad de la supresión de médula ósea con: supresores médula ósea, analgésicos pirazolónicos, penicilamina, agentes citotóxicos y antipsicóticos inyectables depot de larga duración.
- Aumento del riesgo de colapso circulatorio con: benzodiazepinas.
- Potencia la acción de: anticolinérgicos, antihipertensores.
- Aumento de los efectos centrales de: alcohol, IMAO, depresores del SNC.
- Aumento de concentraciones plasmáticas de fármacos con elevada unión a proteínas.

- Concentración plasmática disminuida por: fenitoína.
- Aumenta el riesgo de desarrollar SNM con litio.
- Nivel plasmático disminuido con: inductores CYP1A2 (omeprazol).
- Nivel plasmático aumentado con: inhibidores CYP1A2 (fluvoxamina, cafeína, ciprofloxacino).

★ Efectos secundarios/adversas:

Leucopenia/disminución del recuento leucocitario/neutropenia, eosinofilia, leucocitosis; aumento de peso; somnolencia/sedación, mareo, visión borrosa, cefalea, temblor, rigidez, acatisia, síntomas extrapiramidales, crisis epilépticas/convulsiones/espasmos mioclónicos; taquicardia, cambios en ECG; hipertensión, hipotensión postural, síncope; estreñimiento, hipersalivación, náusea, vómito, anorexia, boca seca; aumento de enzimas hepáticas; incontinencia y retención urinaria; fatiga, fiebre, hipertermia benigna, trastornos de sudoración/regulación de temperatura.

Manejo de sobredosis

- Medidas de urgencia y sostén.

Se debe administrar carbón vegetal activado si la ingestión fue abundante o reciente. En caso de hipotensión grave puede ser necesario el tratamiento con soluciones intravenosas y vasopresores. La hipertermia se debe tratar como se describe. Debe mantenerse la vigilancia cardíaca.

- Tratamiento específico

La hipotensión por lo general responde a bolos de solución salina intravenosa; las arritmias cardíacas relacionadas con el intervalo QRS ancho en el ECG responden algunas veces al bicarbonato de sodio vía IV, como se usa para los antidepresivos tricíclicos. La prolongación del intervalo QT y la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado casi siempre se tratan con magnesio vía IV o con electroestimulación cardíaca de alta frecuencia.

En caso de signos extrapiramidales se administra difenhidramina, 0.5 a 1 mg/kg por vía IV o mesilato de bztropine, 0.01 a 0.02 mg/kg por vía IM. El tratamiento por VO de estos fármacos debe continuar por 24 a 48 h.

La bromocriptina (2.5 a 7.5 mg por VO al día) puede ser efectiva en el síndrome neuroléptico maligno leve o moderado. El dantroleno (2 a 5 mg/kg por vía IV) también se ha usado para la rigidez muscular, pero no es un antídoto real. Para la hipertermia grave es preferible la parálisis neuromuscular rápida.

Referencias

- (2016). Psicosis (síndrome psicótico). “Salvador Zubirán” I, & Herrero A(Eds.), *Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencias*, 7e. McGraw-Hill Education.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1846§ionid=130562883>
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5). 5ª ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013.
- Smollin C (2024). Sobredosis de fármacos antipsicóticos. Papadakis M.A., & McPhee S.J., & Rabow M.W., & McQuaid K.R.(Eds.), *Diagnóstico clínico y tratamiento* 2024. McGraw Hill.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3463§ionid=286767232>
- Spain, V. V. (s. f.). ★ *Vademecum.es - Su fuente de conocimiento farmacológico*.
<https://www.vademecum.es/>
- Whalen, K., Feild, C., & Radhakrishnan, R. (2018). *Pharmacology*. LWW.